FORTALEZA MÉDICA 2030

PLAN ESTRATÉGICO PROSPECTIVO 2027–2030

GOBERNANZA · RESPONSABILIDAD · RESULTADOS

LIBRO DE GOBIERNO

Consejo Regional V 2027–2030

Una propuesta institucional para anticipar el futuro, ordenar prioridades, asignar responsabilidades, ejecutar con disciplina y rendir cuentas de forma pública.

DEFENSA	DESARROLLO	SERVICIO	TRANSPARENCIA	PARTICIPACIÓN



Documento público · Elecciones CMP 2026 · Colegio Médico del Perú · Consejo Regional V Arequipa

ÍNDICE EDITORIAL

PARTE I	**EL FUTURO QUE DEBEMOS ANTICIPAR** **Carta · Resumen ejecutivo · Prospectiva · Diagnóstico · Tendencias · Escenarios**
PARTE II	**EL COLEGIO QUE QUEREMOS CONSTRUIR** **Visión 2030 · Modelo institucional · Competencias A–E**
PARTE III	**CÓMO LO CONSTRUIREMOS** **Siete ejes · Cuatro políticas transversales · Nueve proyectos estratégicos**
PARTE IV	**CÓMO LO EJECUTAREMOS** **Primeros 100 días · Roadmap · Gobernanza · Sostenibilidad · Riesgos**
PARTE V	**CÓMO PODRÁN EVALUARNOS** **KPI · Tablero público · Participación · Responsabilidad · Rendición · Anexos**

GOBERNAR ES CONSTRUIR CAPACIDAD INSTITUCIONAL



CARLOS YOVANI CUYA MAMANI
Candidato a Decano Regional
Médico Cirujano · Cirugía General · CMP 22096 · RNE 11040 · Recertificación CMP 2026–2031

EL DECANO CONDUCE E INTEGRA; EL EQUIPO GESTIONA.

Competencias claras, responsabilidades asignadas, portafolio de proyectos, indicadores, riesgos, aprendizaje y rendición de cuentas.

PARTE I

EL FUTURO QUE DEBEMOS ANTICIPAR

Contexto, diagnóstico, tendencias y escenarios para decidir con anticipación y prudencia.

Carta a nuestros colegas médicos



Carlos Yovani Cuya Mamani · Candidato a Decano Regional

Los médicos en nuestra región de Arequipa trabajamos hoy en escenarios diversos: hospitales y redes de salud públicas, seguridad social, práctica privada, universidades, investigación, primer nivel de atención, servicios especializados y territorios con necesidades diferentes. Esa diversidad exige que el Colegio Médico sea capaz de representar sin simplificar, orientar sin prometer lo que no controla y construir espacios comunes sin sustituir a otras instituciones.

FORTALEZA MÉDICA 2030 propone una gestión del Consejo Regional V Arequipa basado en responsabilidades claras. El Decano conduce e integra; la Secretaría General coordina; cada Secretaría responde por resultados de su responsabilidad; los accesitarios aportan continuidad y soporte transversal. La responsabilidad política es colectiva y la ejecución debe quedar documentada.

No ofrecemos un listado de promesas. Proponemos un sistema: diagnóstico, prioridades, proyectos, responsables, indicadores, riesgos, evidencia y rendición de la gestión realizada. Los primeros 100 días estarán dedicados a auditar, ordenar, activar pilotos, convocar, descentralizar de manera realista, medir y rendir cuentas. El periodo 2027–2030 seguirá una secuencia planificada estratégicamente: ordenar, consolidar, integrar e institucionalizar.

El Consejo Regional V no administra hospitales ni decide plazas, remuneraciones, residencia médica o SERUMS. Su fortaleza legítima está en aquello que sí puede hacer: orientar, representar, articular, desarrollar capacidades profesionales, promover ética, generar conocimiento, contribuir técnicamente al debate sanitario y gestionar con transparencia.

Nuestro compromiso central es que cada propuesta pueda ser seguida públicamente: qué se prometió, quién responde, qué se hizo, qué resultado obtuvo, qué recurso utilizó, qué cambió y por qué. Un Colegio confiable no es el que afirma que todo salió bien; es el que puede explicar sus decisiones y corregir a tiempo.

FORTALEZA MÉDICA · Un equipo de gobierno para el Consejo Regional V Arequipa

Resumen ejecutivo

FORTALEZA MÉDICA 2030 convierte una visión institucional en un sistema de ejecución y evaluación pública.

COMPONENTE	SÍNTESIS
Desafío	Pasar de una institución percibida principalmente por trámites o respuestas reactivas a un Consejo cercano, útil, técnico, ético, transparente, territorial, científico, digital y adaptativo.
Propuesta de valor	DEFENSA + DESARROLLO + SERVICIO + TRANSPARENCIA + PARTICIPACIÓN.
Estrategia	7 ejes, 4 políticas transversales, 9 proyectos estratégicos, primeros 100 días, roadmap 2027–2030 y sistema público de resultados.
Gobernanza	Decano conduce; Secretaría General coordina y monitorea; Secretarías desarrollan resultados especializados; responsables operativos ejecutan; accesitarios sostienen continuidad transversal.
Evaluación	Cobertura, oportunidad, calidad, resultado y transparencia; tablero público; reportes trimestrales; memoria anual.
Disciplina por competencias	A ejecutar; B gestionar/acordar; C articular; D incidir; E no prometer.

Siete ejes

1. Defensa del ejercicio profesional.
2. Ética, deontología y confianza.
3. Desarrollo profesional, ciencia e innovación.
4. Incidencia en salud pública.
5. Gestión, economía y transparencia.
6. Médico joven y renovación.
7. Modernización del Colegio.

Cuatro políticas transversales

- Bienestar profesional médico.
- Medicina, inteligencia artificial y transformación digital responsable.
- Colegio Médico en la región.
- Gobernanza de datos, privacidad y ciberseguridad.

RESULTADO ESPERADO

En 2030, el Consejo Regional V Arequipa debe poder demostrar servicios con trazabilidad, programas con resultados medibles, presencia en la región, formación pertinente, orientación profesional, voz técnica documentada, gestión económica transparente y mecanismos visibles de corrección y rendición de cuentas.

Por qué pensar al 2030

La prospectiva no predice el futuro: obliga a probar si las decisiones siguen siendo útiles bajo condiciones diferentes.

El horizonte 2030 permite evitar dos extremos: administrar solamente la urgencia cotidiana o prometer una transformación instantánea. El plan utiliza escenarios y señales de cambio para identificar capacidades que serían valiosas en más de un futuro plausible.

Decisiones robustas

- Ruta única de orientación y guía de competencias.
- Líneas base y sistema público de resultados.
- Servicios híbridos, simples y trazables.
- Formación continua por competencias.
- Ética digital e IA responsable.
- Bienestar profesional con orientación y derivación.
- Presencia territorial basada en acceso y respuesta, no solo visitas.
- Documentación, memoria institucional y transferencia.

PRINCIPIO PROSPECTIVO

Los escenarios son futuros plausibles utilizados para probar decisiones. No son pronósticos ni promesas.

Diagnóstico estratégico 2026

El problema institucional no se reduce solamente a falta de recursos. El desafío es convertir dispersión, incertidumbre y dependencia de personas en gobernanza, procesos, información y continuidad.

Cinco capacidades institucionales

CAPACIDAD	DEFINICIÓN OPERATIVA
EJECUTAR	Servicios y acciones que el Consejo Regional V controla dentro de su competencia.
GESTIONAR	Organizar recursos, procesos, acuerdos y proyectos propios.
ARTICULAR	Coordinar actores autónomos sin sustituirlos.
REPRESENTAR	Defender y expresar institucionalmente intereses profesionales legítimos.
INCIDIR	Aportar evidencia y recomendaciones para influir en decisiones que corresponden a terceros.

Problemas priorizados

- Orientación profesional dispersa y dificultad para identificar qué puede hacer el CR V.
- Necesidad de mayor trazabilidad de compromisos, recursos, resultados y desviaciones.
- Servicios y procesos que pueden simplificarse sin confundir digitalización con modernización.
- Necesidad de bienestar profesional con enfoque preventivo y de promoción de la salud.
- Brechas de acceso y participación territorial.
- Formación profesional fragmentada frente a nuevas competencias científicas, digitales y éticas.
- Transiciones complejas del médico joven entre colegiatura, SERUMS, residencia, empleo, especialización y desarrollo profesional.
- Necesidad de una voz técnica regional prudente, independiente y basada en evidencia.
- Dependencia excesiva de personas, archivos dispersos o acuerdos sin seguimiento.

Prioridad inicial

NIVEL	ÁMBITOS
MUY ALTA	Orientación y defensa de cada médico · transparencia y trazabilidad · modernización de servicios · bienestar · descentralización.
ALTA	Ética preventiva · médico joven · desarrollo profesional · IA y competencias digitales · participación · representación.
MEDIA-ALTA	Investigación · práctica independiente · articulación con sector privado.
HABILITADORES	Universidades, sociedades científicas, redes profesionales y alianzas técnicas.

Tendencias y señales de cambio

El Plan debe observar tendencias que pueden alterar la práctica médica y la relación entre profesionales, instituciones y ciudadanía.

DIMENSIÓN	TENDENCIAS / SEÑALES A MONITOREAR
Tecnología	IA generativa y clínica; telemedicina; automatización administrativa; interoperabilidad; nuevos riesgos de privacidad y sesgo.
Profesión médica	Nuevos regímenes laborales; movilidad; recertificación; presión regulatoria; exposición reputacional y digital.
Bienestar	Burnout y riesgos psicosociales; violencia y hostigamiento; conciliación; reintegración después de crisis profesionales.
Demografía de salud del médico	Envejecimiento, cronicidad, demanda de continuidad de cuidados y mayor complejidad asistencial.
Sistema de salud	Fragmentación y crisis de las instituciones de salud, restricciones de capacidad, necesidad de articulación entre niveles y sectores.
Confianza pública	Expectativa de transparencia, evidencia, rendición, comunicación clara y respuesta ante desinformación.

DIMENSIÓN	TENDENCIAS / SEÑALES A MONITOREAR
Gobernanza	Mayor necesidad de datos, trazabilidad, protección de información, ciberseguridad y continuidad institucional.

RADAR AREQUIPA MÉDICA
El Consejo Regional V debe revisar periódicamente señales relevantes, documentar qué cambió y decidir si un proyecto continúa, se corrige, se integra o se cierra.

Escenarios 2030

Dos incertidumbres estructuran cuatro futuros plausibles: velocidad/calidad de transformación digital y nivel de cohesión profesional e institucional.

ESCENARIO	CONFIGURACIÓN	RIESGO	CAPACIDAD CLAVE
Continuidad Institucional	Transformación gradual + alta cohesión	Lentitud y complacencia	Orden, participación y mejora incremental.
Aceleración Digital Fragmentada	Transformación acelerada + baja cohesión	Tecnología sin gobernanza; brechas	Ética digital, datos, ciberseguridad y soporte híbrido.
Fragmentación Profesional	Transformación gradual + baja cohesión	Desafección, silos y baja participación	Orientación, representación y territorio.
Colegio Adaptativo	Transformación acelerada + alta cohesión	Sobrecarga por cambio continuo	Aprendizaje, integración y prospectiva.

Respuesta común a los cuatro escenarios

- Información y orientación confiables.
- Gobernanza de proyectos y riesgos.
- Formación continua y ética profesional.
- Capacidad territorial híbrida.
- Datos útiles sin sobreexposición.
- Rendición de cuentas y corrección pública.

PARTE II

EL COLEGIO QUE QUEREMOS CONSTRUIR

Una institución cercana, útil, técnica, ética, transparente, territorial, científica, digital, participativa y adaptativa.

Visión 2030

Una visión institucional debe ser observable en servicios, comportamientos, información y resultados; no solo inspiradora.

VISIÓN 2030

En 2030, el Consejo Regional V Arequipa debe funcionar como una institución profesional cercana, útil, técnicamente sólida, ética y transparente; capaz de ofrecer servicios accesibles y progresivamente digitales, integrar a médicos de Arequipa metropolitana y provincias, fortalecer el desarrollo científico y profesional, incorporar mecanismos permanentes de participación y adaptar sus decisiones mediante datos, evaluación, prospectiva y aprendizaje institucional.

Cercano	Acceso, orientación, respuesta y canales territoriales.
Útil	Servicios que resuelven, orientan o derivan con claridad.
Técnico	Posiciones y decisiones con fuentes, metodología y seguimiento.
Ético	Prevención, orientación, debido proceso y atención a dilemas emergentes.
Transparente	Compromisos, responsables, gastos cuando corresponda, avances, desviaciones y evidencia.
Digital	Procesos simples, híbridos, seguros y centrados en el usuario.
Descentralizado	Acceso territorial, participación y seguimiento, no solo presencia física.
Científico	Formación, investigación, redes y producción técnica.
Participativo	Canales para informarse, consultar, proponer, deliberar y evaluar.
Adaptativo	Revisión de riesgos, señales, resultados y decisiones de continuidad.

Modelo institucional

El Plan traduce propósito en valor, capacidades y resultados; y cada iniciativa debe indicar con qué tipo de competencia se ejecutará.

NIVEL	CONTENIDO
Propósito	Fortalecer el ejercicio médico y la confianza social.
Valor	Defensa · Desarrollo · Servicio · Transparencia · Participación.
Capacidades	Gobernanza · Personas · Procesos · Tecnología · Datos · Alianzas.
Resultados	Colegio cercano · útil · ético · científico · transparente · territorial · digital · adaptativo.

Clasificación obligatoria de competencia

CLASE	ALCANCE	VERBO PÚBLICO
A · Competencia directa	El CR V controla razonablemente el producto.	Ejecutar / implementar.
B · Requiere acuerdo o gestión	Depende de aprobación, presupuesto o sistema institucional superior.	Gestionar / acordar.
C · Requiere articulación	Necesita cooperación de actores autónomos.	Articular / coordinar.
D · Incidencia	La decisión final corresponde a otra institución.	Proponer / representar / incidir.
E · Fuera de competencia	No corresponde prometer ejecución.	Eliminar como promesa.

REGLA PÚBLICA

FORTALEZA MÉDICA asume responsabilidad por aquello que el Consejo Regional V puede ejecutar o gestionar. Cuando el resultado dependa de terceros, la rendición se centrará en qué hizo el Colegio, ante quién actuó y qué respuesta obtuvo.

UN EQUIPO PARA GESTIONAR

Responsabilidades diferenciadas · conducción colegiada · continuidad institucional



El modelo institucional se apoya en un equipo con responsabilidades específicas. La fotografía grupal se conserva como documento visual original.

 **Carlos Yovani Cuya Mamani** **Decano Regional** **Conduce · integra · representa · prioriza**	 **Ricardo Javier Ibañez Barreda** **Secretaría General** **Coordina · monitorea · da continuidad**	 **Daniel Fernando Salas Palma** **Ética y Deontología** **Ética preventiva · debido proceso · confianza**	 **César Iván Chávez López** **Desarrollo Profesional y Científico** **Formación · ciencia · mentoría**	 **Roxana Ruth Quequezana Marín** **Incidencia en Salud Pública** **Evidencia · articulación · voz técnica**
 Edwing Washington Bustinza Flores Asuntos Contenciosos y Administrativos Orientación · representación · seguimiento	 Karelia Silva Velasco Economía y Finanzas Recursos · sostenibilidad · transparencia	 Cinthya Tatiana Cornejo Gallegos Médico Joven Orientación · mentoría · participación	 Maritza Rocha Bustinza Accesitaria Continuidad · soporte transversal	 Gustavo Quispe Quispe Accesitario Continuidad · soporte transversal

RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO

MISMA DIGNIDAD VISUAL · RESPONSABILIDADES CLARAS · RENDICIÓN COLECTIVA

PARTE III

CÓMO LO CONSTRUIREMOS

Siete ejes, políticas transversales y un portafolio concentrado de proyectos con responsables, riesgos e indicadores.

EJE 1 — DEFENSA DEL EJERCICIO PROFESIONAL

Las consultas y problemas profesionales pueden dispersarse entre instituciones y procedimientos, generando incertidumbre sobre qué corresponde al Colegio y cómo recibir orientación.

OBJETIVO 2030

Consolidar un sistema regional de orientación, representación y seguimiento que permita al médico saber qué puede hacer el Consejo Regional V Arequipa, cómo solicitar apoyo y qué respuesta institucional puede esperar.

Resultado observable en 2030

Colegiados con una ruta clara para consultar, conocer el alcance de la intervención colegial y seguir el estado de su orientación.

Iniciativas priorizadas

N.º	INICIATIVA	MECANISMO	COMPETENCIA
1	Ruta única de orientación profesional	Consulta → clasificación → orientación → derivación → seguimiento → cierre.	A
2	Guía pública de competencias	Explicar qué puede ejecutar, gestionar, articular, representar o solo incidir el CR V.	A
3	Registro agregado del ejercicio profesional	Analizar de manera anonimizada problemas recurrentes y señales del ejercicio médico.	A/B
4	Agenda anual de defensa profesional	Priorizar pocos temas de representación o incidencia con evidencia.	A/D

Responsabilidad

Decanato + Secretaría General + Secretaría de Asuntos Contenciosos y Administrativos.

Indicadores públicos

- Tiempo de primera respuesta.
- Casos con cierre o derivación documentada.
- Utilidad percibida de la orientación.
- Problemas recurrentes con seguimiento institucional.

Riesgo principal y control

- Riesgo: prometer solución de asuntos ajenos a la competencia del CR V.
- Control: clasificación A–E de cada caso y asesoría especializada cuando corresponda.

REGLA DE COMPETENCIA

El Consejo Regional V no promete modificar contratos, remuneraciones, plazas o decisiones de empleadores. Puede orientar, representar, gestionar o incidir dentro de sus atribuciones.

EJE 2 — ÉTICA, DEONTOLOGÍA Y CONFIANZA

Una ética entendida solo como respuesta disciplinaria llega tarde frente a dilemas de confidencialidad, comunicación, datos, tecnología, investigación e inteligencia artificial.

OBJETIVO 2030

Fortalecer un modelo preventivo de ética que combine orientación, educación, actualización, deliberación profesional y respeto estricto del debido proceso.

Resultado observable en 2030

Ética integrada como competencia profesional permanente, con orientación preventiva diferenciada de los procedimientos formales.

Iniciativas priorizadas

N.º	INICIATIVA	MECANISMO	COMPETENCIA
1	Programa de ética preventiva	Módulos breves sobre consentimiento, confidencialidad, conflicto de interés, comunicación y práctica digital.	A
2	Ruta informativa deontológica	Canal preventivo para dudas generales dentro de los alcances institucionales.	A
3	Agenda de ética digital e IA	Privacidad, sesgo, supervisión humana, documentación y límites de delegación.	A/B
4	Actualización deontológica continua	Casos, foros y materiales de consulta alineados con normativa vigente.	A

Responsabilidad

Secretaría de Ética y Deontología.

Indicadores públicos

- Cobertura de formación preventiva.
- Tiempo de respuesta informativa.
- Actualizaciones temáticas publicadas.
- Utilidad percibida de materiales y actividades.

Riesgo principal y control

- Riesgo: confundir orientación preventiva con procedimiento disciplinario o presentar lineamientos regionales como regulación general.
- Control: separación explícita de funciones y referencia permanente al marco normativo del CMP.

REGLA DE COMPETENCIA

El CR V puede educar, orientar y aplicar procedimientos que le correspondan; no puede modificar unilateralmente el Código de Ética ni regular de manera general tecnologías o prácticas fuera de sus atribuciones.

EJE 3 — DESARROLLO PROFESIONAL, CIENCIA E INNOVACIÓN

La actualización profesional puede permanecer fragmentada entre instituciones, especialidades y etapas de carrera mientras crecen las necesidades científicas, digitales y de gestión.

OBJETIVO 2030

Construir un sistema colegial de desarrollo profesional concentrado en formación por competencias, investigación y mentoría, y red académica y científica, integrando innovación e IA como contenidos transversales.

Resultado observable en 2030

Tres líneas estables y evaluables: formación por competencias, investigación y mentoría, y red académica/científica con productos verificables.

Iniciativas priorizadas

N.º	INICIATIVA	MECANISMO	COMPETENCIA
1	Formación por competencias	Rutas priorizadas según necesidades verificadas; incluye competencias clínicas, de gestión, ética, comunicación y alfabetización digital/IA.	A/B/C
2	Investigación y mentoría	Metodología, mentoría, ética de investigación, apoyo a producción científica y evaluación de productos.	A/C
3	Red académica y científica	Articulación con universidades, sociedades científicas, investigadores y hospitales; incluye repositorio de oportunidades sin duplicar funciones.	C

Responsabilidad

Secretaría de Desarrollo Profesional y Científico.

Indicadores públicos

- Cobertura formativa.
- Aplicabilidad de la formación.
- Mentorías y productos científicos apoyados con evidencia de avance.
- Alianzas académicas con producto verificable; no se contabilizan convenios sin actividad.

Riesgo principal y control

- Riesgo: medir éxito por número de eventos o asumir funciones de certificación/recertificación que correspondan a órganos nacionales.
- Control: coordinación con las instancias competentes y evaluación de aprendizaje/utilidad.

REGLA DE COMPETENCIA

El CR V organiza y articula educación continua; la certificación, recertificación, grados o acreditaciones formales se rigen por los órganos y procedimientos competentes.

EJE 4 — INCIDENCIA EN SALUD PÚBLICA

El Colegio puede aportar una voz técnica regional, pero debe diferenciar incidencia profesional de autoridad sanitaria y evitar pronunciamientos sin producto ni seguimiento.

OBJETIVO 2030
Consolidar al Consejo Regional V como actor técnico responsable en debates sanitarios regionales mediante evidencia, deliberación profesional, articulación y comunicación pública.

Resultado observable en 2030

Voz técnica regional prudente, documentada, independiente y capaz de seguir las respuestas a sus recomendaciones.

Iniciativas priorizadas

N.º	INICIATIVA	MECANISMO	COMPETENCIA
1	Agenda anual de prioridades	Seleccionar 3–5 temas según relevancia, evidencia y posibilidad de contribución profesional.	A
2	Informes técnicos Consejo Regional V	Problema → evidencia → análisis → alternativas → recomendaciones.	A/D
3	Foros de salud regional	Deliberación con expertos, universidades, sociedades e instituciones; cada foro genera producto.	A/C
4	Educación pública basada en evidencia	Materiales de comunicación sobre temas seleccionados, diferenciados de campañas oficiales.	A/C
5	Mesa de articulación técnica	Diálogo con actores sanitarios cuando exista un problema concreto y producto esperado.	C/D

Responsabilidad

Secretaría de Incidencia en Salud Pública.

Indicadores públicos

- Productos técnicos con fuentes y fecha.
- Foros/mesas con acta, informe o recomendación.
- Recomendaciones prioritarias con seguimiento.
- Respuestas institucionales documentadas.

Riesgo principal y control

- Riesgo: presentarse como autoridad sanitaria o atribuirse resultados poblacionales.
- Control: distinguir con claridad contribución técnica, articulación e incidencia de la capacidad ejecutiva del Estado.

REGLA DE COMPETENCIA

El Consejo Regional V no administra hospitales, redes, vigilancia epidemiológica, presupuestos sanitarios ni contratación pública. Puede proponer, representar y hacer seguimiento ante las autoridades competentes.

EJE 5 — GESTIÓN, ECONOMÍA Y TRANSPARENCIA

La confianza institucional exige que el colegiado pueda comprender prioridades, recursos, proyectos, avances, resultados y razones de las desviaciones.

OBJETIVO 2030

Instalar un modelo de gestión sostenible, medible y transparente que vincule planificación, recursos, proyectos, indicadores y rendición de cuentas.

Resultado observable en 2030

Gestión en la que los compromisos pueden seguirse desde su aprobación hasta su resultado, gasto cuando corresponda, evidencia y siguiente decisión.

Iniciativas priorizadas

N.º	INICIATIVA	MECANISMO	COMPETENCIA
1	Tablero público de gestión	Estado, hitos, KPI, evidencia, gasto cuando corresponda, última actualización y próximo paso.	A
2	Reporte económico comprensible	Información financiera regional explicada y vinculada a prioridades.	A/B
3	Presupuesto vinculado a prioridades	Relacionar proyectos relevantes con objetivos estratégicos dentro del proceso institucional de aprobación.	A/B
4	Sistema de indicadores	Pocos KPI públicos por Secretaría y métricas operativas internas.	A
5	Calendario de rendición	100 días + trimestral + semestral + anual.	A

Responsabilidad

Secretaría de Economía y Finanzas + Secretaría General + Decanato.

Indicadores públicos

- Compromisos con actualización vigente.
- Reportes publicados en plazo.
- Proyectos prioritarios con avance documentado.
- Desviaciones presupuestarias explicadas.

Riesgo principal y control

- Riesgo: confundir transparencia con volumen documental o asumir libre disposición de recursos fuera de los procedimientos del CMP.
- Control: información comprensible, trazable y sujeta al marco presupuestario institucional.

REGLA DE COMPETENCIA

El Consejo Regional V formula, administra y rinde dentro de sus competencias y procedimientos; no compromete recursos no aprobados ni crea obligaciones permanentes sin evaluación de sostenibilidad.

EJE 6 — MÉDICO JOVEN Y RENOVACIÓN

Las transiciones entre egreso, colegiatura, SERUMS, residencia, especialización, empleo y desarrollo profesional dependen de múltiples instituciones y pueden ser difíciles de manejar en el tiempo.

OBJETIVO 2030

Construir un sistema de integración, orientación, mentoría y participación que acompañe al médico durante las primeras etapas de su trayectoria profesional.

Resultado observable en 2030

Médicos jóvenes con acceso a información validada, mentoría, iniciación científica y participación institucional, sin atribuir al CR V resultados de empleo, residencia o SERUMS.

Iniciativas priorizadas

N.º	INICIATIVA	MECANISMO	COMPETENCIA
1	Orientación e información validada	Información organizada sobre colegiatura, SERUMS, residencia, formación y oportunidades, identificando siempre la institución competente.	A/C
2	Red de mentoría	Acompañamiento en carrera, especialidad, investigación, docencia y gestión, con objetivos y cierre documentado.	A/C
3	Iniciación científica	Mentoría coordinada con Desarrollo Profesional y productos definidos.	A/C
4	Participación institucional	Incorporación a comisiones, grupos técnicos y proyectos con mandato concreto.	A

Responsabilidad

Secretaría del Médico Joven.

Indicadores públicos

- Mentorías iniciadas y completadas.
- Participación en proyectos.
- Utilidad de la orientación.
- Diversidad institucional y territorial de participantes.

Riesgo principal y control

- Riesgo: prometer empleo, residencia o resultados de SERUMS.
- Control: guías que identifiquen con claridad la autoridad competente y los límites del Consejo Regioonal V.

REGLA DE COMPETENCIA

El Consejo Regional V informa, orienta, ofrece mentoría y articula oportunidades; no asigna plazas, no decide admisión a residencia ni garantiza empleo.

EJE 7 — MODERNIZACIÓN DEL COLEGIO

Digitalizar formularios no equivale a modernizar. El desafío es reducir fricción, tiempos e incertidumbre sin excluir atención humana ni comprometer datos.

OBJETIVO 2030

Rediseñar progresivamente servicios y procesos regionales prioritarios y digitalizar solo cuando la tecnología aporte valor verificable, con acceso híbrido, trazabilidad y seguridad.

Resultado observable en 2030

Servicios regionales con menor fricción y seguimiento verificable; la solución tecnológica se elige después de rediseñar el proceso y comprobar necesidad, costo y sostenibilidad.

Iniciativas priorizadas

N.º	INICIATIVA	MECANISMO	COMPETENCIA
1	Rediseño de servicios prioritarios	Mapear procesos, eliminar pasos innecesarios, identificar usuario y definir experiencia objetivo antes de digitalizar.	A
2	Acceso digital regional seguro	Usar la solución tecnológica mínima necesaria para información, agenda, documentos y seguimiento; integrarse con sistemas del CMP solo cuando exista compatibilidad y autorización.	A/B
3	Guía y seguimiento de trámites	Requisitos, responsable, canal, tiempo referencial y estado de procesos regionales.	A/B

N.º	INICIATIVA	MECANISMO	COMPETENCIA
4	Modelo omnicanal	Presencial + web + correo + móvil + videoconferencia según necesidad y capacidad.	A
5	Datos para mejorar servicios	Uso agregado de tiempos, demanda, consultas, reprocesos y satisfacción, con minimización de datos.	A

Responsabilidad

Secretaría General como responsable operativo; Decanato como conducción estratégica; Secretarías como propietarias de sus procesos.

Indicadores públicos

- Servicios priorizados rediseñados.
- Tiempo de proceso.
- Reprocesos.
- Experiencia de usuario.
- Incidentes de seguridad y continuidad.

Riesgo principal y control

- Riesgo: digitalizar burocracia, crear plataformas insostenibles o excluir usuarios.
- Control: REDISEÑAR PRIMERO → DIGITALIZAR DESPUÉS; ningún desarrollo propio, integración, infraestructura o licencia recurrente se compromete sin necesidad demostrada, proceso rediseñado, usuario identificado, costo total, compatibilidad, seguridad, mantenimiento y decisión STOP/GO.

REGLA DE COMPETENCIA.

La integración con plataformas nacionales o sistemas de terceros requiere gestión y autorización; el Consejo Regional V no modificará unilateralmente sistemas institucionales fuera de su control.

Políticas transversales

Cuatro políticas cruzan todos los ejes y evitan convertir problemas sistémicos en nuevos "ejes" aislados.

1 Bienestar Profesional Médico

El bienestar se abordará como una responsabilidad institucional acotada a PREVENIR → ORIENTAR → DERIVAR/ACOMPAÑAR. La primera fase no incluye atención clínica propia ni tratamiento psicológico o psiquiátrico institucional; cualquier expansión requerirá demanda demostrada, competencia, recursos y evaluación.

NIVEL	ACCIÓN
Prevención	Educación sobre riesgos psicosociales, violencia, hostigamiento, autocuidado profesional, conciliación y apoyo entre pares.
Orientación	Ruta única: consulta → clasificación → orientación → derivación/acompañamiento → seguimiento → cierre.
Derivación	Red de recursos externos competentes; derivar no significa desentenderse.
Acompañamiento	Información procedural, apoyo institucional permitido y seguimiento agregado.
Incidencia	Transformar problemas recurrentes en evidencia y propuestas ante quienes corresponda.

LÍMITE

El Consejo Regional V no promete reducir el burnout regional en un porcentaje ni resolver conflictos laborales que dependan de empleadores. Sí puede prevenir, orientar, articular y representar dentro de su competencia.

2 Medicina, Inteligencia Artificial y Transformación Digital Responsable

Esta política no constituye un proyecto autónomo. Sus funciones se ejecutan a través de P03 (acceso digital, seguridad y privacidad), P05 (ética digital, responsabilidad y supervisión humana) y P06 (alfabetización, evaluación crítica, innovación y formación).

- Educar: alfabetización en IA, evaluación crítica de herramientas y supervisión humana.
- Orientar: consultas sobre documentación, privacidad, telemedicina, investigación y educación médica.

- Generar lineamientos institucionales: uso interno y recomendaciones profesionales dentro del marco vigente.
- Incidir: elevar propuestas regulatorias o técnicas a las instancias competentes.
- Evaluar tecnologías digitales con criterios de necesidad, evidencia, seguridad, sesgo, privacidad, transparencia, integración, costo y responsabilidad.

PRINCIPIO

La IA puede ampliar capacidades profesionales, pero no sustituye el juicio clínico, la responsabilidad médica, la deliberación ética ni la relación médico-paciente.

3 Colegio Médico en la región

La expansión territorial no será automática. Antes de seleccionar pilotos se aplicará una matriz de priorización con cuatro criterios: DISTANCIA/ACCESO + DEMANDA PROFESIONAL + BRECHA DE SERVICIO + FACTIBILIDAD. Solo se ampliará cobertura cuando el piloto demuestre uso, capacidad de respuesta, costo sostenible y seguimiento.

DIMENSIÓN	COMPROMISO
Presencia física	Agenda territorial selectiva con propósito, producto y seguimiento; no turismo institucional.
Acceso digital	Orientación, información, formación, participación y rendición accesibles a distancia.
Participación	Consultas y mecanismos que permitan proponer y evaluar.
Representación	Problemas territoriales llegan a la agenda y decisión institucional.
Capacidad de respuesta	Cada problema aceptado tiene responsable, respuesta, seguimiento y evidencia.

4 Gobernanza de datos, privacidad y ciberseguridad

- Minimización de datos: recoger solo lo necesario.
- Clasificación de información y controles de acceso.
- Copias de seguridad, continuidad y respuesta a incidentes.
- No publicar expedientes, datos clínicos, consultas identificables ni información sensible.
- Revisión de privacidad y seguridad antes de escalar servicios digitales.

Portafolio estratégico

Diez proyectos concentrados. El portafolio reemplaza la proliferación de actividades aisladas y permite asignar responsable, recurso, hito, KPI, dependencia y riesgo.

CÓD.	PROYECTO	PRIORIDAD	EJE	LIDERAZGO	INTENSIDAD INICIAL
P01	Sistema Integral de Orientación y Defensa Profesional	P1	1+7	Asuntos Contenciosos	Media
P02	Colegio Transparente y Gestión por Resultados	P1	5 transversal	Economía + SG	Baja–Media
P03	Modernización y Acceso Digital Seguro	P1	7	SG	Media / alta si requiere desarrollo
P04	Bienestar Profesional Médico	P1	Transversal	Decanato	Media
P05	Ética Preventiva, Deontología y Confianza Digital	P1	2	Ética y Deontología	Baja–Media
P06	Desarrollo Profesional, Ciencia y Mentoría	P2	3	Desarrollo Profesional	Media
P07	Orientación, Mentoría y Participación del Médico Joven	P2	6	Médico Joven	Baja–Media
P08	Colegio en Territorio	P2	Transversal	Decanato	Media
P09	Arequipa Salud: Agenda Técnica y Voz Profesional	P3	4	Incidencia en Salud Pública	Baja–Media

PARTE IV

CÓMO LO EJECUTAREMOS

Instalar capacidad, ordenar prioridades, activar pilotos, medir y corregir antes de escalar.

Primeros 100 días

Los 100 días deben instalar capacidad mínima de gobierno y prueba, no presentar todos los frentes como igualmente maduros. Se distinguirá explícitamente: INSTALADO ≠ PILOTADO ≠ EVALUADO ≠ CONSOLIDADO.

DÍAS	VERBO	ACCIÓN	RESPONSABLE	PRODUCTO / MADUREZ
1–15	AUDITAR	Inventario de servicios/procesos; revisión económico-administrativa; mapa de proyectos, convenios, activos digitales, consultas y riesgos.	Decanato + SG + áreas	Informe de situación y línea base · INSTALADO
16–30	ORDENAR	Definir portafolio de 9 proyectos; responsables; competencias; Comité de Seguimiento; tablero inicial y prueba de asequibilidad preliminar.	Decanato + SG + Economía	Gobernanza y portafolio aprobados · INSTALADO
31–60	ACTIVAR	Ruta Única de Orientación en piloto; guía de competencias; tablero v1; protocolos iniciales de ética, bienestar y modernización.	Secretarías responsables	Núcleo operativo mínimo · PILOTADO
61–80	DISEÑAR / CONVOCAR	Diseño de red académica, médico joven, agenda técnica y territorio priorizado; identificación de aliados y dependencias.	Secretarías responsables + accesitarios según asignación	Frentes no fundacionales · EN DISEÑO/PILOTO
81–90	MEDIR	Primera revisión de uso, tiempos, experiencia, riesgos, recursos y decisiones de continuar/corregir/pausar.	Comité de Seguimiento	Informe de revisión · EVALUADO INICIALMENTE
91–100	RENDIR CUENTAS	Publicar línea base disponible, tablero, brechas, desviaciones, proyectos diferidos y agenda 101–180 días.	Decanato + SG	Informe de instalación y línea base · PUBLICADO

Productos al día 100 según nivel de madurez

- OBLIGATORIOS: informe de situación y línea base; portafolio definitivo de 9 proyectos; responsables y gobernanza; guía de competencias; Ruta Única de Orientación en piloto; Tablero Público v1; Informe Público de Instalación y Línea Base.
- EN DISEÑO O PILOTO: bienestar; territorio; médico joven; red académica; agenda técnica de salud pública; ética preventiva; modernización digital.
- REGLA: ningún producto en diseño o piloto se presentará como consolidado; su continuidad dependerá de uso, capacidad, costo, riesgo y evidencia.

Roadmap 2027–2030

Cada año cumple una función diferente. No se inicia todo en 2027.

AÑO	VERBO	PRIORIDAD	RESULTADO ESPERADO	CRITERIO DE TRANSICIÓN
2027	ORDENAR	Activar núcleo P01/P02/P05; pilotar P03/P04/P07/P08; desplegar P06/P09 solo según capacidad y asequibilidad.	Institución organizada y medible, con simultaneidad controlada.	Responsables; líneas base esenciales; orientación y tablero funcionando; pilotos evaluados; proyectos no asequibles diferidos.
2028	CONSOLIDAR	Calidad, cobertura, continuidad, alianzas y sostenibilidad de los proyectos que superaron STOP/GO.	Servicios estables y útiles.	Indicadores comparables; utilidad demostrada; capacidad de mantenimiento.
2029	INTEGRAR	Datos, servicios, territorio, ciencia y participación; reducir duplicidades.	Colegio conectado, con menos silos.	Estándares comunes; datos alimentando decisiones; dependencias controladas.
2030	INSTITUCIONALIZAR	Evaluar, documentar, transferir y actualizar prospectiva.	Capacidades que permanecen.	Responsable + proceso documentado + recurso + KPI + evidencia + continuidad.

Decisiones anuales del portafolio

REGLA

CONTINUAR · ESCALAR · CORREGIR · FUSIONAR · CERRAR. El calendario no obliga a escalar un proyecto que no ha demostrado utilidad o sostenibilidad.

Gobernanza

La arquitectura de gobierno separa conducción, coordinación, responsabilidad por resultados y ejecución operativa. Secretaría General coordina, registra, monitorea y escala problemas; no ejecuta materialmente todos los productos.

NIVEL	FUNCIÓN
Decano	Conducción estratégica, integración, representación, priorización y rendición general.
Secretaría General	Coordinación institucional, acuerdos, cronograma, alertas, tablero y continuidad operativa.
Secretarías	Propietarias de objetivos, proyectos, productos, KPI, riesgos y reportes de su ámbito.
Accesitarios	Soporte transversal y continuidad en proyectos o comisiones formalmente asignados.
Comisiones / alianzas	Apoyo técnico y ejecución específica sin sustituir responsabilidad de la Secretaría.

Comité de Seguimiento Estratégico

- Revisión mensual de proyectos y riesgos.
- Revisión trimestral de estrategia y cartera.
- Evaluación anual de continuidad, escalamiento o cierre.
- Toda sesión termina con decisión, responsable, plazo y evidencia esperada.

Matriz de liderazgo de proyectos

PROYECTO	ACCOUNTABLE INSTITUCIONAL	RESPONSABLE OPERATIVO	COPARTICIPACIÓN / APOYO TÉCNICO
P01	Asuntos Contenciosos	Responsable operativo designado para orientación	SG · Decanato · asesoría especializada cuando corresponda
P02	Economía y Finanzas	Responsable operativo de seguimiento/reportes designado	SG · Decanato
P03	Secretaría General	Responsable técnico/digital designado	Secretarías propietarias de procesos · soporte técnico
P04	Decanato	Coordinación operativa de bienestar designada	Ética · Contenciosos · Médico Joven · red externa
P05	Ética y Deontología	Responsable operativo de programa designado	Desarrollo Profesional
P06	Desarrollo Profesional y Científico	Responsable operativo académico designado	Médico Joven · universidades · sociedades científicas
P07	Médico Joven	Responsable operativo de mentoría/participación	Desarrollo Profesional
P08	Decanato	Coordinación territorial designada	Accesitarios · Secretarías · SG como coordinación institucional
P09	Incidencia en Salud Pública	Responsable operativo de agenda técnica	Desarrollo Profesional · Decanato · expertos

Financiamiento y sostenibilidad

El Plan no inventa presupuestos. Clasifica intensidad de recursos y exige costo total antes de comprometer gasto recurrente.

INTENSIDAD	DEFINICIÓN
BAJA	Organización, tiempo profesional e infraestructura existente.
MEDIA	Dedicación sostenida, soporte técnico, movilidad, servicios específicos, formación o pequeñas contrataciones.
ALTA	Desarrollo tecnológico, infraestructura, licencias, integración, personal dedicado o costo recurrente significativo.

Fuentes y modalidades posibles

- Recursos propios dentro del presupuesto aprobado.
- Infraestructura existente.
- Alianzas institucionales.
- Cofinanciamiento y cooperación cuando sean legalmente procedentes.
- Patrocinio permitido con transparencia y manejo de conflictos de interés.
- Voluntariado profesional para actividades delimitadas, sin reemplazar funciones permanentes esenciales.

Prueba de asequibilidad y cinco decisiones económicas

DECISIÓN	CRITERIO	APLICACIÓN
ACTIVAR	Bajo costo, competencia clara, responsable, capacidad disponible y valor inmediato.	Guías, protocolos, tablero inicial, repositorios y servicios simples.
PILOTAR	Costo o incertidumbre media; medir uso, calidad y carga antes de escalar.	Bienestar, territorio, mentoría, nuevas rutas formativas y analítica.
EVALUAR INVERSIÓN	Costo alto o recurrente; exige caso de inversión, costo total, seguridad y sostenibilidad.	Desarrollo tecnológico, integraciones, infraestructura, licencias o personal permanente.

DECISIÓN	CRITERIO	APLICACIÓN
DIFERIR	Necesario pero no asequible o sin capacidad suficiente en el periodo.	Se conserva como opción documentada sin iniciar gasto.
NO EJECUTAR	No supera prueba de competencia, valor, sostenibilidad o riesgo.	Se cierra o reformula; no se busca financiamiento para sostener una mala solución.
REGLA PRESUPUESTARIA NO SE PRESUPUESTA UNA ACTIVIDAD PORQUE SEA ATRACTIVA. SE ASIGNA UN RECURSO PORQUE EXISTE UNA PRIORIDAD, UN PRODUCTO, UN INDICADOR Y UN RESULTADO ESPERADO.		

Costo total

Antes del Plan Operativo 2027, cada proyecto estimará costo inicial, costo anual, horas-persona, tecnología, movilidad, contratación, mantenimiento y seguridad. Si la capacidad es insuficiente, se reducirá alcance antes de buscar nueva financiación.

PARTE V

CÓMO PODRÁN EVALUARNOS

Indicadores, transparencia, participación, riesgos y evidencia para rendir cuentas públicamente.

KPI y Sistema Público de Resultados

La evaluación pública distingue cinco niveles para evitar confundir actividad con resultado. Son una taxonomía de evaluación, no una obligación de publicar cinco KPI por proyecto. Cada proyecto seleccionará preferentemente 3–5 KPI públicos: al menos uno de acceso/oportunidad, uno de calidad, uno de resultado y uno de transparencia cuando agregue valor.

NIVEL	PREGUNTA	KPI NÚCLEO
COBERTURA	¿A quién llegamos?	Orientación registrada · cobertura formativa · cobertura territorial.
OPORTUNIDAD	¿A tiempo?	Tiempo de primera respuesta · tiempo de proceso · vigencia de actualización.
CALIDAD	¿Funcionó bien?	Utilidad de orientación · aplicabilidad formativa · experiencia digital.
RESULTADO	¿Qué cambió?	Cierre/derivación · aprendizaje demostrado · incidencia con seguimiento · reducción de fricción.
TRANSPARENCIA	¿Puede verificarse?	Compromisos con evidencia · rendición en plazo · desviaciones explicadas.

Regla de línea base

TEXTO OBLIGATORIO

Cuando no exista un valor inicial verificable: “Línea base a establecer durante el periodo inicial de gestión.” La meta cuantitativa se definirá después de conocer la línea base, la capacidad y las dependencias.

Ficha técnica de cada KPI

- Código y nivel.
- Definición y propósito.
- Numerador, denominador y unidad cuando corresponda.
- Fuente y responsable del dato.

- Responsable del resultado.
- Frecuencia y fecha de corte.
- Línea base y meta.
- Desagregaciones permitidas.
- Limitaciones y reglas de calidad

Transparencia y Tablero Público CR V 2030

La transparencia debe permitir seguir una decisión desde el compromiso original hasta su resultado, incluidos cambios, costos, evidencia y correcciones.

Campos públicos por proyecto

CAMPO	CONTENIDO
Código / proyecto	Identificador permanente y nombre.
Responsable	Secretaría o Decanato accountable.
Estado	PROGRAMADO · INICIADO · EN CURSO · CON DESVIACIÓN · CUMPLIDO · REPROGRAMADO.
Avance	Hitos completados / hitos definidos; no porcentaje arbitrario.
KPI	Línea base, meta cuando exista y último valor.
Gasto	Presupuesto/ejecución cuando corresponda y sea publicable.
Documentos	Fichas, acuerdos, informes, protocolos, evaluaciones.
Riesgo	Alerta principal y respuesta.
Última actualización	Fecha de corte.
Siguiente paso	Acción y plazo.

Regla de estados

ESTADO	DEFINICIÓN
PROGRAMADO	Aprobado y calendarizado, aún no iniciado.
INICIADO	Instalación, preparación o piloto inicial.
EN CURSO	Ejecución activa con evidencia de avance.
CON DESVIACIÓN	Diferencia relevante respecto de plazo, alcance, costo, producto o indicador.
CUMPLIDO	Hito o resultado definido alcanzado con evidencia verificable.
REPROGRAMADO	Cambio formal explicado, con nueva fecha/alcance y conservación del historial.

TRAZABILIDAD

TODA MODIFICACIÓN CREA UNA NUEVA VERSIÓN: ANTES → CAMBIO → RAZÓN → QUIÉN AUTORIZÓ → CUÁNDO → NUEVO HITO. No borrar, no reemplazar silenciosamente, no retroactuar estados.

Participación médica permanente

La participación es una función de gobierno y mejora institucional; no una herramienta de propaganda, perfilamiento político o captación electoral.

MECANISMO	FINALIDAD	PRODUCTO
Consultas abiertas	Recoger aportes sobre políticas, servicios o documentos.	Informe de consulta y respuesta.
Foros	Deliberar sobre problemas complejos.	Acta, síntesis o recomendación.
Comisiones	Trabajo técnico con mandato y plazo.	Entregable definido.
Agenda anual	Priorizar temas donde la participación pueda modificar decisiones.	Calendario público.
Encuestas institucionales	Conocer necesidades, experiencia o prioridades.	Informe metodológico; no confundir con representatividad estadística.
Propuestas colegiadas	Canalizar iniciativas de los médicos.	Registro, evaluación, decisión y seguimiento.
Publicación de respuestas	Explicar qué se incorporó, derivó o descartó y por qué.	Respuesta pública agregada.

REGLA DE CAPACIDAD: NO ABRIR UNA CONSULTA SIN RESPONSABLE + PLAZO + PRODUCTO + CAPACIDAD DE RESPUESTA. La participación no debe generar más demanda de la que la institución puede procesar.

Métricas

- Participantes únicos y tasa de participación cuando exista denominador válido.
- Diversidad institucional y territorial.
- Participación nueva versus recurrente.
- Propuestas con respuesta documentada.
- Mediana de tiempo de respuesta.
- Propuestas incorporadas total o parcialmente con trazabilidad.
- Propuestas no incorporadas con explicación.

SALVAGUARDA

Queda excluido usar encuestas o datos institucionales para inferir intención de voto, segmentar afinidades políticas, crear bases de simpatizantes o dirigir propaganda.

Gestión de riesgos

El registro de riesgos es una herramienta de decisión. Un riesgo conocido debe tener señal temprana, propietario y mitigación.

RIESGO	PROB.	IMPACTO	INDICADOR TEMPRANO	MITIGACIÓN	RESPONSABLE
Regulatorio	Media	Alto	Cambio normativo u observación a iniciativa	Revisión normativa; matriz de competencia; versionado	SG + Decanato
Financiero	Media	Alto	Proyectos sin fuente; gasto recurrente creciente	Priorización; pilotos; costo total; sostenibilidad	Economía + Decanato
Reputacional	Media	Alto	Compromisos sin actualización; errores públicos	Corrección pública; evidencia; vocería	Decanato + SG
Tecnológico	Media	Alto	Bajo uso, fallas, incompatibilidad	Pilotos; modularidad; soporte; TCO	SG + soporte técnico
Operativo	Alta	Alto	Hitos vencidos y sobrecarga	Priorizar; limitar portafolio; STOP/GO	SG + Comité
Jurídico	Media	Alto	Reclamos u observaciones legales	Asesoría especializada; documentación	Decanato + SG
Ético	Media	Crítico	Conflictos no declarados; patrocinio condicionado	Declaración de conflictos; revisión ética	Ética + Decanato
Ciberseguridad	Media	Crítico	Accesos anómalos, incidentes, indisponibilidad	MFA; backups; mínimo dato; respuesta a incidentes	SG + soporte
Participación insuficiente	Media	Medio–Alto	Baja participación y mismos grupos	Canales híbridos; devolución; diversidad	SG + Secretarías

RIESGO	PROB.	IMPACTO	INDICADOR TEMPRANO	MITIGACIÓN	RESPONSABLE
Dependencia de terceros	Alta	Alto	Convenios o respuestas demoradas	Plan alternativo; hitos condicionados	Responsable proyecto + SG
Discontinuidad	Media	Crítico	Procesos no documentados; archivos personales	Repositorio; RACI; manuales; transferencia	SG + Decanato
Calidad de datos	Alta al inicio	Alto	KPI sin fuente o discrepancias	Diccionario KPI; auditoría; responsable del dato	SG + áreas

Protocolo de activación para riesgos críticos

RIESGO CRÍTICO	UMBRAL DE ACTIVACIÓN	RESPUESTA INMEDIATA	ESCALAMIENTO	EVIDENCIA DE CIERRE
Ciberseguridad	Acceso no autorizado confirmado, exposición potencial de datos o indisponibilidad relevante.	Contener, preservar evidencia, restringir accesos y activar soporte especializado.	Decanato + SG; asesoría técnica/jurídica según alcance.	Informe de incidente, causa, corrección, recuperación y validación.
Ético / conflicto de interés	Conflicto no declarado o condicionamiento externo sobre contenido, decisión o datos.	Suspender la decisión/actividad afectada y revisar independencia.	Ética + Decanato; órgano competente si corresponde.	Declaración, decisión documentada y salvaguarda aplicada.
Financiero	Proyecto con gasto recurrente sin fuente aprobada o costo total no sostenible.	Detener nuevos compromisos y recalcular alcance.	Economía + Decanato + Consejo Regional.	Decisión ACTIVAR/PILOTAR/DIFERIR/NO EJECUTAR y fuente validada.
Regulatorio / jurídico	Cambio normativo u observación que cuestione competencia o legalidad de una iniciativa.	Pausar la parte afectada y revisar norma vigente.	Decanato + SG + asesoría especializada.	Dictamen/revisión documentada y versión corregida o cierre.

RIESGO CRÍTICO	UMBRAL DE ACTIVACIÓN	RESPUESTA INMEDIATA	ESCALAMIENTO	EVIDENCIA DE CIERRE
Discontinuidad	Proceso crítico sin documentación, repositorio o transferencia antes de cambio de responsable.	Documentar, transferir accesos y asignar sustitución operativa.	SG + Decanato.	Acta de transferencia, proceso actualizado y acceso institucional verificado.

CICLO DE RIESGO

SEÑAL → RIESGO → RESPONSABLE → MITIGACIÓN → DECISIÓN → EVIDENCIA → APRENDIZAJE.

Responsabilidad del equipo

La función institucional pertenece al cargo.

INTEGRANTE	CARGO	RESPONSABILIDAD PÚBLICA	CAPACIDAD DOCUMENTADA PERTINENTE
Carlos Yovani Cuya Mamani	Decano Regional	Conducción, integración, representación, priorización y rendición general.	Experiencia en gestión sanitaria regional, red, hospital, EsSalud, docencia y práctica clínica.
Ricardo Javier Ibañez Barreda	Secretaría General	Coordinación, acuerdos, seguimiento y continuidad operativa.	Especialista en Psiquiatría, docente universitario y jefe de servicio hospitalario.
Daniel Fernando Salas Palma	Ética y Deontología	Prevención, orientación deontológica, actualización y ética digital.	Urología, docencia/coordinación universitaria, tutoría, Gerencia en Salud y formación/ponencias en ética y deontología.
César Iván Chávez López	Desarrollo Profesional y Científico	Educación continua, ciencia, investigación, innovación y articulación académica.	Patología Clínica, docencia universitaria nombrada, jefaturas de servicios diagnósticos y formación en Gerencia en Salud.
Roxana Ruth Quequezana Marín	Incidencia en Salud Pública	Agenda técnica, informes, foros, articulación e incidencia.	Primer nivel, microrredes, salud mental comunitaria, gestión y Gerencia de Servicios de Salud.
Edwing Washington Bustinza Flores	Asuntos Contenciosos y Administrativos	Orientación, clasificación, derivación y seguimiento administrativo.	Cirugía, auditoría médica, gestión y representación gremial.
Karelia Silva Velasco	Economía y Finanzas	Priorización, sostenibilidad, información económica y rendición.	Maestría en Administración y Gestión en Salud, docencia y conducción en sociedad científica.
Cinthya Tatiana Cornejo Gallegos	Médico Joven	Orientación, mentoría, iniciación científica y participación.	Neurología, auditoría médica, salud pública, primer nivel y experiencia territorial.

INTEGRANTE	CARGO	RESPONSABILIDAD PÚBLICA	CAPACIDAD DOCUMENTADA PERTINENTE
Maritza Rocha Bustinza	Accesitaria	Continuidad y soporte transversal, especialmente primer nivel, educación y territorio.	Primer nivel EsSalud/MINSA, Maestría en Educación Superior y experiencia en capacitación.
Gustavo Quispe Quispe	Accesitario	Continuidad y soporte transversal, especialmente redes, territorio y gestión.	Dirección de red, dirección hospitalaria, jefatura de microred, cirugía y docencia.

PRINCIPIO

Responsabilidad temática individual + responsabilidad colectiva por el Plan. La continuidad no puede depender de una sola persona.

Cómo podrán evaluarnos

El criterio no será cuántas actividades se anunciaron, sino si el CR V instaló capacidades útiles, medibles, sostenibles y transferibles.

Preguntas públicas de evaluación

PREGUNTA	EVIDENCIA ESPERADA
¿Llegó el servicio a quien lo necesitaba?	Cobertura y diversidad territorial/institucional.
¿Respondió oportunamente?	Tiempos de primera respuesta y proceso.
¿Funcionó con calidad?	Utilidad, aplicabilidad, reprocesos, experiencia.
¿Produjo un resultado?	Cierre/derivación, aprendizaje, seguimiento de recomendaciones, mejora operativa.
¿Puede comprobarse?	Tablero, documentos, gasto cuando corresponda, historial de cambios.
¿Aprendió la institución?	Correcciones, proyectos cerrados/fusionados, riesgos gestionados y memoria.
¿Puede continuar?	Proceso documentado, responsable, recurso, KPI y transferencia.

Calendario público

FRECUENCIA	PRODUCTO	CONTENIDO
100 días	Informe de instalación y línea base	Punto de partida, ordenamiento, pilotos y brechas.
Trimestral	Dashboard actualizado	KPI, hitos, alertas, desviaciones y próximos pasos.
Semestral	Informe de avance	Ejes, proyectos, riesgos, correcciones y resultados.
Anual	Memoria de gestión	Comparación con línea base, aprendizajes y prioridades siguientes.
2030	Evaluación y transferencia	Resultados del periodo, institucionalización y agenda futura.

CRITERIO FINAL

Una capacidad se considera institucionalizada cuando tiene responsable, proceso documentado, recurso identificado, indicador, evidencia de uso y posibilidad de continuar sin depender de una persona específica.

Anexos técnicos

Los anexos concentran definiciones para evitar repetir metodología en cada capítulo.

Anexo A. Matriz de competencia A–E

TIPO	PREGUNTA DE CONTROL	EJEMPLO
A	¿El CR V controla el producto final?	Orientación, tablero, informes, formación propia.
B	¿Requiere acuerdo, presupuesto o sistema institucional superior?	Portal integrado, presupuesto, procesos nacionales CMP.
C	¿Requiere cooperación de actor autónomo?	Red académica, formación con universidades, mesas con hospitales.
D	¿La decisión final corresponde a otra entidad?	Condiciones laborales, política sanitaria, recursos del sistema.
E	¿Es una función ajena que no debe prometerse?	Asignar plazas, administrar hospitales, decidir SERUMS/residencia, regular tecnología externa.

Anexo B. Diccionario resumido de KPI

CÓD.	NIVEL	INDICADOR	DEFINICIÓN / FÓRMULA
C1	Cobertura	Cobertura de orientación	Solicitudes clasificadas / solicitudes elegibles × 100.
C2	Cobertura	Cobertura formativa	Participantes únicos / población objetivo cuando exista denominador válido.
C3	Cobertura	Cobertura territorial	Territorios con acceso activo / territorios priorizados.
O1	Oportunidad	Tiempo de primera respuesta	Mediana desde ingreso formal hasta primera respuesta útil.
O2	Oportunidad	Tiempo de proceso	Mediana por tipo de servicio.

CÓD.	NIVEL	INDICADOR	DEFINICIÓN / FÓRMULA
O3	Oportunidad	Actualización vigente	Compromisos actualizados en plazo / compromisos a actualizar.
Q1	Calidad	Utilidad de orientación	Respuestas favorables / respuestas válidas.
Q2	Calidad	Aplicabilidad formativa	Participantes que reportan aplicabilidad / respuestas válidas.
Q3	Calidad	Experiencia digital	Satisfacción + finalización + ausencia de reproceso según metodología aprobada.
R1	Resultado	Cierre o derivación documentada	Casos cerrados o correctamente derivados / casos gestionables.
R2	Resultado	Aprendizaje demostrado	Cambio pre/post cuando metodológicamente corresponda.
R3	Resultado	Incidencia con seguimiento	Recomendaciones prioritarias con seguimiento / recomendaciones prioritarias.
R4	Resultado	Reducción de fricción	Cambio en tiempo, pasos o reproceso frente a línea base.
T1	Transparencia	Compromisos con evidencia	Compromisos con ficha pública completa / compromisos activos.
T2	Transparencia	Rendición en plazo	Reportes en plazo / reportes programados.
T3	Transparencia	Desviaciones explicadas	Desviaciones con causa, impacto, corrección y nuevo hito / desviaciones relevantes.

Anexo C. Ficha mínima de proyecto

- Código y nombre.
- Problema, necesidad y objetivo.
- QUIÉN: accountable institucional + responsable operativo + RACI.
- COMPETENCIA A/B/C/D/E.
- PRODUCTO e hito verificable.
- RECURSO y horas-persona requeridas.
- COSTO inicial y recurrente cuando corresponda.
- PLAZO y nivel de madurez esperado.
- DEPENDENCIAS y parte controlada por terceros.
- KPI, línea base, fuente y meta cuando exista.
- EVIDENCIA pública esperada.
- RIESGO y umbral relevante.
- PLAN B / alternativa mínima viable.
- DECISIÓN STOP/GO: activar, pilotar, evaluar inversión, diferir, reformular, fusionar o cerrar.

PRUEBA ADVERSARIAL: ¿Quién lo hará? ¿Con qué competencia? ¿Con qué recursos? ¿En cuánto tiempo? ¿De quién depende? ¿Qué ocurre si falla? ¿Cómo se mide? ¿Qué evidencia demostrará cumplimiento? ¿Qué parte depende de terceros? ¿Es realmente necesario? Si una respuesta es débil, el proyecto se reduce, difiere, fusiona o cierra.

Anexo D. Lista roja de promesas que no debe contener el Plan

- Crear o asignar plazas de trabajo.
- Garantizar vacantes o admisión a residencia médica.
- Decidir resultados del SERUMS.
- Modificar remuneraciones, contratos o turnos de terceros.
- Aumentar directamente camas, personal o medicamentos del sistema sanitario.
- Administrar hospitales, redes o vigilancia epidemiológica.
- Regular unilateralmente IA clínica o autorizar tecnologías sanitarias.

- Modificar normas nacionales por decisión regional.
- Garantizar resultados poblacionales de salud.
- Recertificar fuera de los procedimientos oficiales.
- Otorgar grados académicos o sustituir comités de ética de investigación.
- Integrar plataformas nacionales sin autorización o crear gasto permanente sin aprobación.

Anexo E. Base normativa y documental

- Ley N.º 15173 / normativa de creación y desarrollo del Colegio Médico del Perú, según texto vigente aplicable.
- Estatuto del Colegio Médico del Perú, Resolución N.º 293-CN-CMP-2023 y rectificaciones/modificaciones vigentes.
- Reglamento del Colegio Médico del Perú, Resolución N.º 435-CN-CMP-2024 y modificaciones vigentes.
- Código de Ética y Deontología y reglamentos específicos aplicables.
- Acuerdos del Consejo Nacional y Consejo Regional que resulten aplicables durante la gestión.

Nota de control normativo: antes de ejecutar iniciativas que involucren competencias disciplinarias, presupuesto, sistemas nacionales, comisiones locales, recertificación, protección de datos o contratación, deberá verificarse la norma vigente y el acuerdo institucional correspondiente.

Anexo F. Glosario de integridad

TÉRMINO	DEFINICIÓN
Actividad	Acción ejecutada; por sí sola no demuestra resultado.
Producto	Entregable verificable generado por una actividad.
Resultado	Cambio observable vinculado al proyecto.
Impacto	Cambio de mayor alcance que puede depender de múltiples actores; no debe atribuirse sin diseño causal suficiente.
Meta	Valor objetivo; no es un logro hasta comprobarse.
Evidencia	Documento, registro o dato que permite verificar una afirmación.
Desviación	Diferencia relevante frente a plazo, costo, alcance, producto o indicador.
Reprogramación	Cambio formal con razón, autorización, nuevo hito y conservación del historial.

FORTALEZA MÉDICA 2030

GESTIONAR ES ASUMIR RESPONSABILIDAD POR LO QUE SE PROPONE, LO QUE SE HACE Y LO QUE SE OBTIENE.

EL PLAN EN UNA SOLA MIRADA

Arquitectura estratégica de FORTALEZA MÉDICA 2030

7 EJES Defensa · Ética · Desarrollo · Salud Pública · Gestión · Médico Joven · Modernización	**4 POLÍTICAS** Bienestar · IA responsable · Territorio · Datos, privacidad y ciberseguridad
9 PROYECTOS Portafolio concentrado con responsables, productos, KPI, riesgos y decisiones	**100 DÍAS** Auditar · Ordenar · Activar · Diseñar/Convocar · Medir · Rendir cuentas
2027–2030 Ordenar · Consolidar · Integrar · Institucionalizar	**5 NIVELES** Cobertura · Oportunidad · Calidad · Resultado · Transparencia

VISIÓN → ESTRATEGIA → RESPONSABILIDAD → EJECUCIÓN → MEDICIÓN → APRENDIZAJE → RENDICIÓN

SÍNTESIS VISUAL 02

DISCIPLINA DE COMPETENCIA

Prometer solo aquello que el CR V puede ejecutar, gestionar, articular o incidir

A · DIRECTA EJECUTAR / IMPLEMENTAR · El CR V controla razonablemente el producto.	**B · ACUERDO O GESTIÓN** GESTIONAR / ACORDAR · Requiere aprobación, presupuesto o sistema superior.
C · ARTICULACIÓN ARTICULAR / COORDINAR · Necesita cooperación de actores autónomos.	**D · INCIDENCIA** PROPONER / REPRESENTAR / INCIDIR · La decisión final corresponde a terceros.
E · FUERA DE COMPETENCIA NO PROMETER · Eliminar como promesa de ejecución.	**REGLA PÚBLICA** Cuando el resultado depende de terceros, rendir cuentas por lo hecho, ante quién y qué respuesta se obtuvo.

HECHO ≠ PROPUESTA · PROPUESTA ≠ RESULTADO · META ≠ LOGRO · ESCENARIO ≠ PREDICCIÓN

SÍNTESIS VISUAL 03

ARQUITECTURA DE RESPONSABILIDAD

Conducción colegiada con funciones diferenciadas y rendición colectiva

DECANO Conduce · integra · representa · prioriza · rinde cuentas.	**SECRETARÍA GENERAL** Coordina · registra · monitorea · alerta · sostiene continuidad.
SECRETARÍAS Responden por objetivos, proyectos, productos, KPI, riesgos y reportes de su ámbito.	**ACCESITARIOS** Aportan continuidad y soporte transversal en asignaciones formalizadas.
COMISIONES / ALIANZAS Aportan soporte técnico o ejecución específica sin sustituir la responsabilidad institucional.	**COMITÉ DE SEGUIMIENTO** Revisa proyectos y riesgos; decide continuar, escalar, corregir, fusionar o cerrar.

EL DECANO CONDUCE E INTEGRA; EL EQUIPO GOBIERNA.

SÍNTESIS VISUAL 04

DEL COMPROMISO A LA EVIDENCIA

Sistema público de resultados y corrección

1 · COMPROMISO Qué se aprobó y qué resultado se espera.	**2 · RESPONSABLE** Quién responde institucionalmente y quién ejecuta.
3 · HITO Qué producto verificable debe existir y cuándo.	**4 · KPI** Cómo se observará cobertura, oportunidad, calidad, resultado o transparencia.
5 · EVIDENCIA Qué documento, dato o producto permite verificar el avance.	**6 · DESVIACIÓN / CORRECCIÓN** Qué cambió, por qué y qué decisión se toma.

REPROGRAMAR ≠ OCULTAR · ACTIVIDAD ≠ IMPACTO · TRANSPARENCIA = TRAZABILIDAD + EXPLICACIÓN

CIERRE

GOBERNANZA · RESPONSABILIDAD · RESULTADOS

Un gobierno colegial sólido deja capacidades, procesos, evidencia y memoria institucional.

FORTALEZA MÉDICA 2030



NO SOLO QUÉ.
TAMBIÉN CÓMO, QUIÉN Y CÓMO PODRÁ EVALUARSE.
El Decano conduce e integra. El equipo asume responsabilidades. Los procesos quedan documentados. Los resultados deben poder explicarse, verificarse y corregirse.
CARLOS YOVANI CUYA MAMANI · Candidato a Decano Regional

FORTALEZA MÉDICA 2030

PLAN ESTRATÉGICO PROSPECTIVO 2027–2030

UN EQUIPO PARA EL CONSEJO REGIONAL V AREQUIPA

SÍNTESIS VISUAL 01

FORTALEZA MÉDICA 2030

PLAN ESTRATÉGICO PROSPECTIVO 2027–2030

GOBERNANZA · RESPONSABILIDAD · RESULTADOS

Documento público · Elecciones CMP 2026 · Colegio Médico del Perú · Consejo Regional V Arequipa

UN EQUIPO PARA EL CONSEJO REGIONAL V AREQUIPA